

19 - Suites De Couches - Pr. FAKHIR

Nous allons discuter aujourd'hui, c'est les suites de couches normales et pathologiques. Alors, c'est un chapitre qui reste ou qui est très important à connaître, surtout pour un généraliste. Parce que là, quand on fait les cours d'IAUNA pour vous, c'est des cours pour formation des généralistes.

Donc, on essaye d'insister sur les choses qui vont être utiles pour vous quand vous allez pratiquer dans votre cabinet, quand vous allez être affecté dans un centre de santé ou quelque part dans le pays. Donc, les suites de couches est une partie de la vie de la femme après l'accouchement, juste après l'accouchement, qui peut se passer tout à fait naturellement. Et c'est ce qui est arrivé autrefois pour nos grands-mamans, nos mamans aussi.

Rien ne se passe, tout revient dans l'ordre de façon naturelle, sans aucun problème. Et puis, tout ce qui est culture traditionnelle permet de gérer un petit peu les problèmes qui peuvent survenir. Par contre, et vous avez compris l'autre jour, on a fait ensemble la mortalité maternelle, et on a dit que c'est une mortalité qui peut survenir jusqu'à 41 jours après l'accouchement.

Et donc, toute cette période peut être le moment d'apparition d'une complication. Et là, ça va être une complication de l'accouchement, ou là, une complication de la période des suites de couches. Ce qui fait qu'on devrait comprendre et connaître tout ce qui est normal et pouvoir diagnostiquer et pouvoir... Donc, on devrait connaître tout ce qui est normal, c'est-à-dire quand on parle avec la patiente ou quand on examine la patiente dans les suites de couches, on devrait être capable de dire, oui, ça, c'est normal, c'est naturel, et tranquilliser la patiente, soit dire, au contraire, non, ça, c'est pathologique, et donc, on devrait programmer une prise en charge particulière.

Donc, si on veut définir cette période, c'est justement une période qui débute après les 24 heures. C'est-à-dire que la période des 24 heures post-accouchement, c'est une période du post-partum immédiat. Donc, les complications de cette période sont spécifiques à cette période-là et elles sont marquées essentiellement par l'hémorragie.

C'est-à-dire, ça, c'est le plus important des complications dans cette période des 24 heures. Au-delà des 24 heures, on commence à parler de la période du post-partum ou la période des suites de couches et qui va se prolonger jusqu'au retour des couches. Le retour des couches, c'est-à-dire la reprise des menstruations normales.

En général, cette période-là va durer entre six et huit semaines après l'accouchement, si la femme ne l'aide pas. Parce que si la femme ne l'aide pas, en général, ces règles vont revenir rapidement et ça va se faire dans les trois à six semaines. Et si on compte les huit semaines, ça fait deux mois, donc ça fait 60 jours à peu près, mais elle peut survenir avant dans les 40 jours, c'est-à-dire les six semaines, c'est un mois et demi, c'est 30 plus, c'est 45 jours à peu près.

Donc, on est dans le même concept des 40 jours. Au-delà des 40 jours, la patiente qui ne l'aide pas, c'est-à-dire qui donne un allaitement artificiel, va voir revenir son cycle menstruel rapidement. Ça peut se faire à cette date, comme ça peut se prolonger jusqu'à deux mois, il n'y a pas de problème.

Sauf que cette période-là, il faut savoir que l'ovulation peut survenir à n'importe quel moment et que la patiente, si elle n'est pas sous contraception, elle risque de tomber enceinte encore. Et puis, ça peut se prolonger jusqu'au-delà de trois mois et donc pour une patiente qui ne l'aide pas, ça, ce n'est pas normal, c'est-à-dire que théoriquement, elle devait avoir le retour de couche avant trois mois. Si ça dépasse trois mois, si elle vient se plaindre de ça, oui, il y a un problème.

Donc, je dois faire les investigations nécessaires. Puis pour les patientes qui allaitent, sachez que les patientes allaitantes peuvent ne pas avoir leurs règles pendant toute la période de l'allaitement. C'est-à-dire qu'elles vont être onaménorées pendant toute la période de l'allaitement et surtout si, en plus de ça, on les met sous contraception type micro-progestatif qui, elle aussi, se prend en continu.

Ce n'est pas comme la contraception oestro-progestative dans laquelle on prend les comprimés pendant 21 jours puis on arrête pendant 7 jours et au cours de cet arrêt-là, les règles surviennent parce qu'il y a une chute de la progestérone comme dans le cycle naturel. Mais quand on donne les micro-progestatifs, c'est-à-dire la pilule de l'allaitement, on les prend en continu, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas d'arrêt de cette pilule et donc ça va engendrer une onaménorée aussi. Alors, associés à l'allaitement, les patientes allaitantes, qu'elles soient sous contraception ou pas, vont voir leur date de retour de couche se retarder parfois jusqu'à la fin de l'allaitement, surtout si elles sont en contraception, parfois quand tu auras une diminution de la quantité de l'allaitement, c'est-à-dire quand le nourissant commence à manger, en général c'est à partir de 4 mois et puis au-delà à 6 mois et plus, les TTT, ça devient de plus en plus rare, ça peut se limiter à 2 à 3 TTT par 24 heures, ça, ça va faire chuter 100 taux de prolactine et au fur et à mesure, cette chute de taux de prolactine va lever le blocage sur l'ovaire et va permettre la survenue de l'ovulation et donc elle peut avoir les règles, comme elle peut tomber enceinte, d'accord? Et donc, c'est à ça qu'on doit faire attention.

Et en général, toute cette période de suite de couche, c'est la période au cours de laquelle il y aura un retour du corps maternel à la normale d'avant la grossesse. Il n'y aura jamais un retour à d'intégrum, c'est-à-dire que ça va être exactement qu'avant la grossesse et l'accouchement, mais en tout cas, toutes les fonctions vont pouvoir revenir à la normale avec quelques modifications. Ce qui est important à connaître, c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les suites de couche pathologiques, c'est-à-dire au cours desquelles survient des problèmes pathologiques.

Les plus importants, d'emblée, vous devez le savoir, il y a les infections, et ça c'est les infections génitales et utérines, et ça s'appelle l'endométrite du postpartum. Ça peut être les infections

mammaires qui surviennent chez la patiente, ça va de soi allaitante, voilà, et ça peut aussi être des complications hémorragiques et surtout la maladie thromboembolique, parce que je pense que vous avez compris que la grossesse est un facteur de maladie thromboembolique et c'est un facteur sérieux. Parfois, quand on prescrit la contraception oestroprogestative, et dans la littérature, il y a un risque thromboembolique de la contraception oestroprogestative.

Mais quand vous allez voir dans les recommandations ou dans les travaux, on va dire, vous allez trouver quelque part, que les risques thromboemboliques d'une grossesse ou de plusieurs grossesses peuvent être supérieurs aux risques de la contraception. Et donc, vous voyez que la grossesse est un facteur de risque très important. Que ce soit la grossesse ou la période du postpartum, c'est des périodes où il y a un risque de maladie thromboembolique.

Donc, qu'est-ce qui se passe juste après l'accouchement? Je pense qu'on va avoir de la répétition, donc je vous demande de me pardonner aujourd'hui, parce que je prévoyais revoir le cours la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qui va arriver juste après l'accouchement? C'est-à-dire qu'on va passer d'une situation de patiente gravide, patiente enceinte, avec les modifications anatomiques liées à la gravité, à l'état gravide par la gravité, d'accord? C'est-à-dire l'utérus gravide, qui est un utérus qui est augmenté de taille, qui arrive jusqu'à la griffotide, avec la modification de la vascularisation qui devient très importante, notamment de l'artère utérine, de façon bilatérale, avec un débit très important, tout ce qui est refoulement d'aisance de l'estomac, compression de l'urtère du côté droit surtout, compression de la vessie, tout ça c'est l'état gravide, d'accord? Et donc, vous imaginez qu'immédiatement après l'accouchement, quel que soit le type d'accouchement, que ce soit par voie basse naturelle ou par voie haute par césarienne, on va avoir un changement, et un changement qui va se faire rapidement. Donc immédiatement, on va avoir une involution.

Involution de quoi? De l'utérus. Quand on dit involution, c'est-à-dire qu'il était gros et qu'il va réduire de taille de façon rapide. Et pourquoi? Parce que justement, on va avoir une chute hormonale, et ça on l'a compris avec la délivrance, on va avoir une chute importante de la progestérone, d'accord? Et ça, ça va aider à la libération de la prolactine.

Et aussi au moment des TT, qu'est-ce qui va arriver? Oui, voilà, il y aura un réflexe à partir de la suture qui va libérer l'ocytocine, et cette ocytocine, on sait, c'est l'hormone de la contraction utérine, mais aussi c'est l'hormone de la rétraction utérine. C'est pour ça qu'on dit à la patiente, quand elle allait être les premières TT, elle a mal au niveau de son utérus, ça s'appelle les tranchées, d'accord? On lui dit que, rassurez-vous, c'est une douleur passagère, mais c'est une douleur bénéfique. À votre avis, pourquoi elle est bénéfique? D'abord, il va reprendre sa forme normale, oui.

Quel est le rôle de ce globe de sécurité? Il va prévenir l'hémorragie, parce que plus le muscle utérin va se contracter, plus il va ligaturer les vaisseaux qui nourrissaient le placenta avant, et qui, au moment de la délivrance, s'il n'y a pas cette rétraction, vont rester ouverts et vont saigner,

d'accord? Et d'un autre côté, c'est un moyen, quand l'utérus se rétracte, de chasser tout ce qui peut rester à l'intérieur de l'utérus, que ce soit du sang, du liquide amniotique ou des débris placentaires. Si ils restent à l'intérieur, d'abord, ils vont s'infecter, ils vont nous donner de l'infection puerpérale, c'est-à-dire de l'infection de la période du postpartum. Alors, ce mot puerpéral, c'est un mot qui relie le symptôme à la période du postpartum.

On va voir l'infection puerpérale, on va voir la dépression ou la psychose puerpérale, d'accord? C'est un adjectif qui est lié à la période de suite de couche. Donc, on va voir que ce segment inférieur va disparaître très vite, en deux jours, et vous avez sûrement compris que le segment inférieur, c'est une partie de l'utérus gravidé qui n'existe qu'au cours de la période de la grossesse et surtout au troisième trimestre. Et donc, ça va rapidement disparaître et ça va revenir à cette situation qui est la situation de liaison, d'accord? Et qui va avoir la même épaisseur que le reste du myomètre.

Alors qu'au cours de la grossesse, cette partie de l'utérus est très fine et c'est elle qui permet de transmettre la contraction vers le col et de permettre la dilatation. C'est aussi la zone au niveau de laquelle on fait quoi? L'incision utérine de la césarienne, ce qu'on appelle l'hystérotomie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas épais et puis on peut le suturer rapidement.

Ce n'est pas comme le myomètre. Le myomètre est très gros, surtout le myomètre en postpartum. Vous êtes déjà rentré au blog pour voir des césariennes? Les gens qui sont passés, levez la main.

Tu as vu une césarienne? Les autres? Oui? Vous avez vu comment il est gros le myomètre quand ils sont en train de le suturer. Mais le segment inférieur, il est plutôt fin et facile. Donc si on coupe sur le myomètre, c'est un peu dangereux.

Et donc ce segment inférieur, ça y est, c'est fini. Sa fonction est terminée après l'accouchement. Donc il va disparaître tout de suite après, dans les deux jours qui suivent.

Pour le col utérin, le col utérin qui au cours de l'accouchement normal, surtout parce qu'au cours de la césarienne, si c'est une césarienne programmée ou si c'est une césarienne au début du travail, c'est un col qui ne s'est pas dilaté, qui ne s'est pas effacé. Donc rien n'a changé. Mais une patiente qui a suivi toutes les étapes de l'effacement, puis de la dilatation, puis du passage du mobile foetal, c'est beaucoup de changements.

Donc il va devoir revenir à la normale, c'est-à-dire reprendre sa forme longue, à peu près de 1,5 à 2 cm, la consistante qui est ferme comme celui-là, et ça au bout d'une semaine à peu près. C'est-à-dire que si vous faites un toucher vaginal le deuxième jour ou le troisième jour, vous allez quand même trouver un col qui est très flasque, très gros, très épais, démassé, qui n'est pas ferme comme celui d'avant la grossesse ou d'avant l'accouchement. C'est à ce qu'elle termine son allaitement sans aucun problème parce que c'est une pilule qui est efficace.

C'est le plus important. C'est vrai que quand elle va diminuer un peu son allaitement, elle peut avoir des petits saignements quelquefois, mais théoriquement elle est protégée, il n'y a pas de problème. Mais quand on donne les œstrogènes avec l'allaitement, ce qui arrive c'est qu'il va y avoir une chute de la quantité d'huile lait.

La quantité d'huile lait qu'elle va donner va chuter au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de production lactée parce que les taux élevés d'œstrogène vont un peu gêner l'action de la prolactine. Pour le reste, la vulve après l'accouchement, bien évidemment elle est béante, elle est dilatée, mais ça va revenir au fur et à mesure à la normale. Pour le périnée, lui aussi les muscles périnéaux vont être relâchés.

On parle là de l'accouchement naturel ou normal. Et ça va dépendre aussi du type de l'accouchement et ce qui a été fait. C'est-à-dire si c'est un accouchement qui a été fait dans les règles de l'art, qui se fait doucement, que les poussées se font progressives, qu'on arrête la progression au fur et à mesure que la dilatation musculaire se fait et que l'on ne force pas sur le périnée, en général il n'y aura pas de déchirure, il y aura la béance, mais ça, ça peut être attrapé avec le temps.

En général, on doit dépasser les huit semaines et on peut commencer la kinésithérapie du périnée et on peut reprendre et retrouver le tonus musculaire. Quels sont les muscles qui sont intéressés ici ? Ce sont les muscles de releveur de l'anus et ça c'est un travail qui peut se faire après pour retrouver la tonicité. Le problème se pose quand il y a une épisiotomie qui a été faite ou que le travail soit a été mal contrôlé, soit la patiente a poussé trop vite, soit elle était toute seule, soit la position n'est pas bonne, soit la préparation à l'accouchement n'est pas bonne.

Parce que pourquoi les déchirures se font et pourquoi il y a des dégâts un peu parfois sérieux sur le périnée, c'est parce que les femmes et surtout malheureusement celles de notre population générale, c'est des femmes d'abord qui ont des niveaux d'éducation à la limite du moyen ou inférieur du moyen et deuxièmement, ils n'ont pas, on va dire, même si actuellement l'information elle est présente partout, dans les médias, etc., mais ils n'ont pas cette vision ou cette connaissance comme quoi une femme enceinte peut se préparer à l'accouchement, qu'on ne va pas aller à l'accouchement, on ne connaît ni ce que c'est qu'une contraction, ni quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que ça va s'arrêter, on ne connaît pas le début du travail, la fin du travail, quelle est la position où elle est prête à accoucher, quand est-ce qu'elle va respirer, quand est-ce qu'elle va pousser, quand est-ce qu'elle va relâcher, etc. Tout ça, en général, dans les pays qui se respectent, il est préparé avant. Il est même préparé deux ou trois, quatre mois avant l'accouchement de façon à ce que la patiente un peu visualise qu'est-ce qui va se passer.

Et donc, quand on est dans la salle d'accouchement, en travail, avec la douleur ou parfois avec une période urale, elle sait participer, être active, savoir quand est-ce que pousser, quand est-ce que relâcher, etc. Et en général, ça se passe mieux. Et puis, il y a aussi des séances de renforcement périnéale qui peuvent être faites avec une kiné avant l'accouchement.

Comme ça, elle va connaître comment relâcher son périnée et comment contracter son périnée. Tout ça, ça aide à la protection, justement, du périnée. Ensuite, il y a des modifications qui vont se faire sur la glande mammaire, bien évidemment.

C'est-à-dire que c'est d'abord une préparation à la lactation au cours de la grossesse, puisqu'on a beaucoup d'oestrogènes, beaucoup de progestérone au cours de la grossesse, énormément. On ne peut pas imaginer la quantité d'oestrogènes, de progestérone qu'on a au cours de la grossesse. Et ça va développer les galactophores et les acénies.

Et puis, la prolactine, elle est sécrétée au cours de la grossesse, mais elle est bloquée par la présence de la progestérone au niveau hypophysiaire. Et que dès la délivrance, la lactation va être initiée par la chute de la progestérone et les premières suctions. Et c'est pour ça qu'il faut encourager les premières suctions, même au niveau de la salle d'accouchement, afin que la montée laiteuse ait le temps de se faire, parce qu'elle ne se fait pas le premier jour, ni le deuxième, parfois jusqu'au troisième jour.

Mais on a le colostrum qui est nécessaire et qui doit être donné au nouveau-né. Après, c'est le phénomène de succion, phénomène de remplissage et de vidange, on va en parler un petit peu à la fin, qui va entretenir la production du lait. Modification hormonale qui se fait en postpartum, c'est la chute des taux d'oestrogène et de la progestérone, comme j'ai déjà dit.

L'augmentation de la sécrétion de la prolactine et puis diminution des besoins en insuline. Pourquoi on doit citer ça? C'est pour faire attention aux patientes qui sont sous-insulines, qui sont diabétiques sous-insulines injectables. D'accord? Alors, ces patientes-là, quand elles sont enceintes, surtout le troisième trimestre, je pense que vous avez fait le diabète des grossesses? D'accord.

Donc, il y a une... Est-ce qu'il y a une troisième trimestre? Non, mais à part tout ça, on parle de l'insuline, le diabète, qu'est-ce qui se passe? Physiologiquement, dans les modifications physiologiques chez une femme enceinte, sur le plan diabète-insuline, qu'est-ce qui se passe au troisième trimestre? Il y a une insulino-résistance qui est nécessaire pour libérer tout ce qui a été emmagasiné le premier trimestre. Libérer le glucose, libérer les acides aminés, les acides gras, pour les mettre à disposition d'un fœtus qui est maintenant grand et qui a des besoins importants. D'accord? Et quand on a une résistance à l'insuline, qu'est-ce qui se passe? On a de l'hyperglycémie.

La réaction du corps à l'hyperglycémie, c'est produire de l'insuline. Donc, il y a un hyperinsulinisme aussi associé. Et donc, quand vous avez une patiente qui est diabétique et qui est incapable de faire face à cette hyperglycémie par son propre insuline, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne de l'insuline en injectable, d'accord? Et en général, chez ces patientes-là, les doses d'insuline vers la fin de la grossesse sont importantes pour faire face à cette situation d'insulino-résistance.

Et donc, dès que l'accouchement se fait, tout ce phénomène, bien sûr, va être arrêté, parce que, justement, il n'y a pas cet hormone lactogène placentaire. Et donc, le besoin d'insuline va chuter très vite, d'accord? Et donc, l'insuline endogène va être largement suffisante. Et donc, si on continue à donner de l'insuline injectable de la même façon qu'avant l'accouchement, c'est grave, parce qu'on va mettre la patiente en hypoglycémie dangereuse.

Et c'est pour ça que pour les patientes qui ne sont pas connues diabétiques initialement et qui ont fait le diabète gestationnel, on donne de l'insuline, on arrête l'insuline après. Autrefois, on faisait diviser par deux la dose que la femme prend. Maintenant, les endocrinos disent arrêtez l'insuline, faites la surveillance de la glycémie, et là, on va voir.

Parfois, tout rentre dans l'ordre. Et ça, c'est le diabète gestationnel pur. Parfois, elle va garder une hyperinsuline qui peut être gérée par le régime.

Sinon, ils vont réintroduire soit l'insuline, soit un traitement médical puisqu'elle n'est plus enceinte. Et c'est la même chose pour les diabétiques insulino-dépendants. Là, à la fin de la course, c'est sûr qu'on a augmenté les doses.

Il faut penser à réduire rapidement, immédiatement après l'accouchement, les doses d'insuline parce que les besoins diminuent. Sur le plan hématologique, et ça vous l'avez compris déjà, les modifications physiologiques, c'est qu'il y a une tendance à l'hypercoagulabilité. C'est une tendance qui va s'aggraver encore en postpartum parce que le volume sanguin va diminuer.

Il n'y aura plus l'hémodilution liquide de la grossesse. On aura l'augmentation des globules blancs aussi de la même façon et du fibrinogène. Mais ça ne va se normaliser qu'au bout de trois à quatre semaines.

Et c'est pour ça qu'on donne toujours après la césarienne, dans la prévention thromboembolique, de l'héparine, le bonbon moléculaire à dose préventive pour toutes les patientes opérées du pelvis. Il y en a déjà. La chirurgie du pelvis est un facteur de risque.

Et puis la grossesse est un facteur de risque. Et le postpartum est un facteur de risque. Donc, on couvre ça avec une dose préventive.

Une obésité importante, une cardiopathie face à l'hypocoagulation, on dirait que c'est une dose curative. Je pense qu'il y a un problème avec le thromboembolique. Le tableau des risques, comment tu peux en ajouter un? Sur le plan général, au musculo-squelettique, il va y avoir une relaxation des articulations, une fatigue et parfois le diastasis du muscle abdominal.

Tout ça peut être récupéré plus tard avec une bonne hygiène de vie et une bonne activité physique. Sur le plan psychologique, il y a aussi des modifications physiologiques normales au cours de la période du postpartum. Mais parfois, ça peut ne pas bien se passer et on peut tomber dans la pathologie.

Ce qui arrive, c'est qu'il y a en général quatre phases possibles. Une phase de réflexion, c'est-à-dire que la patiente, pendant un à deux jours, va réfléchir en face d'un nouveau être qui vient d'arriver, surtout si c'est une première part. Elle était toute seule, elle l'avait dans son ventre, mais le voir entre ses bras, devoir répondre à ses besoins 24 heures sur 24, ce n'est pas du tout facile.

Il y a une bonne période où on ne sait même pas ce qui se passe. Puis on va reprendre, surtout quand la patiente se ressent un peu mieux par rapport à sa santé, et en général deux à trois jours plus tard. Et là, elle va commencer, c'est-à-dire qu'elle devient elle-même autonome parce qu'en général, après un accouchement, on est très fatigué, on a besoin de l'aide, et surtout si c'est une césarienne.

Comprenez qu'on ne peut pas se lever, qu'on ne mange pas, qu'on a 24 heures de la douleur, qu'on a 48 heures de la douleur. Devoir s'occuper de ce nouveau-né en plus, c'est quand même très lourd. Plus tard, elle va se rendre compte qu'elle va pouvoir reprendre son esprit au bout de trois jours.

Pour les multiparts, en général, elle comprend plus vite et ça se passe plus sagement, si on peut dire ça. Mais pour les primiparts, je sais que c'est très, très, très difficile. Ce n'est pas du tout évident, et je vous le dis par expérience aussi.

Phase de réalisme, c'est-à-dire quelques semaines plus tard et surtout après le retour à domicile. Et là, la patiente, si elle est forte, il faut qu'elle soit forte psychologiquement aussi, pour pouvoir faire face à toutes les responsabilités qui vont venir. On parle de la femme toute seule ici, tout en sachant que, on va voir plus tard, que l'un des problèmes les plus fréquents, c'est la dépression du postpartum.

Et ce n'est pas rare, c'est fréquent. Heureusement, et j'espère que ça va continuer et que votre génération, ça va être ma génération pour s'occuper des enfants de ma fille ou de mes enfants, mais pour vous, plus tard, la solidarité familiale. Il y a la maman, la belle-maman, qui vient auprès de la femme qui a accouché, qui lui demande de rester dans son lit, qui s'occupe du bébé pendant quelques jours, une semaine, parfois les 40 jours, parce qu'on demande dans notre culture que la patiente, une fille, il faut qu'elle reste dans sa maison, ne sort pas pendant les 40 jours.

Ça, ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas du charabia ou du n'importe quoi. Ça, c'est un soutien psychologique et social de la femme qui vient d'accoucher. Dernièrement, comme tout le monde, je vois des vidéos qui tombent sur ma boîte, sur mon radar, je vois les cultures japonaises, coréennes et aussi, on va dire, l'Extrême-Orient.

Et bien, actuellement, c'est quel pays, je ne sais plus quel pays, celui qui voit un développement très important, Smita? Indonésie? Non? Smita? Malaisie? Alors là, il y a des agents, enfin des femmes, qui font des aides domestiques du postpartum. C'est-à-dire que le gouvernement paye

ces patientes-là pour venir rester 15 jours à la maison de la patiente qui a accouché. Donc, elle va s'occuper d'elle, des soins qu'elle a, elle va lui préparer à manger, toutes les soupes chaudes, etc.

Et il va s'occuper du bébé. Et c'est ça, la période au cours de laquelle la patiente va se reprendre. Elle va reprendre sa santé et aussi, elle va commencer à assimiler les soins qu'elle doit donner à ce nouveau-né au fur et à mesure, doucement.

Et c'est comme ça qu'on ne peut pas tomber dans les situations de dépression grave ou même parfois de psychose pulvérale. Et c'est grave. Donc, j'espère, et c'est un conseil que vous, autour de vous, que vous encouragez ça.

Sachez que vous allez devenir des médecins-aides. Vous allez devenir des acteurs sociaux. Vous avez de la responsabilité à améliorer la qualité de vie et de santé autour de vous.

Vous n'allez pas dire à ma chichoune, il faut encourager, parler autour de vous, dire que oui, c'est bien, encourager votre maman à aller chez sa belle-fille, aller aider sa fille, etc., à fonctionner. Je pense que c'est pas rigolo, parce que ça, c'est vraiment très important. Dans d'autres pays, les femmes peuvent se suicider, peuvent abandonner leur bébé, peuvent entrer dans des conflits conjugaux horribles qui font que les couples éclatent dans la période du postpartum.

Mais ça, je vous dis, la période du postpartum, les couples peuvent éclater. Parce que la maman va recevoir toute la responsabilité de ce nouveau-né. C'est naturel, parce que c'est elle qui a l'aide.

Et parfois, le papa, il se sent éjecté, alors que c'était un couple à deux et que ça se passait bien. Et cette éjection, elle aussi doit être gérée, soit qu'elle va être gérée avec la famille, donc on prend le nourrisson un petit moment et on laisse au couple le temps de se retrouver. Soit, si c'est un papa qui a de l'intelligence, il va aider pour d'abord intégrer le couple enfant-maman et aussi pour aider sa patiente.

Donc tout ça, c'est pas théorique, c'est quelque chose qui devrait être fait. Je vous en parle à l'occasion de cette période du postpartum et à l'occasion que du fait que s'il n'y a pas le soutien pour une femme qui vient d'accoucher, sachez que ça va retentir sur toute sa vie et sur la relation mère-nourrisson. Plus tard, et même, ça peut retentir sur l'état psychologique de l'enfant.

Et enfin, après avoir réussi tout ça, parce qu'il faut le réussir, si elle le rate et ne le réussit pas, l'attachement va être difficile et elle va vivre sa maternité avec toujours une souffrance dans laquelle « mais pourquoi je dois faire tout ça ? » Donc là, c'est les données générales. Bien évidemment, quand vous allez recevoir la patiente dans les suites de couche, et ça, ça s'appelle la consultation du postpartum et en général, on fait ça vers la sixième semaine du postpartum, mais aussi, c'est une consultation qu'on doit faire à l'hôpital, à la maternité, avant la sortie. Donc on doit s'assurer que tout se passe bien avant de dire à la patiente de sortir.

Chez nous, au Maroc, la loi nous dit que, si on va lire les textes, c'est qu'une patiente qui accouche par vos bases, elle doit séjourner au moins 48 heures au niveau de la maternité. Et celle qui accouche par césarienne doit séjourner au moins 72 heures à cinq jours dans la maternité. C'est ce qui arrive aussi dans les pays qui se respectent.

Là, on n'arrive pas à le faire parce qu'on a un flux, et vous avez vu notre hôpital comment il est. Ce n'est pas de notre faute, et ça, je vous le jure, parce que je suis dans cette région depuis d'abord. Et c'est un problème de la région.

Les hôpitaux régionaux ne travaillent pas, parce que, comme vous avez remarqué au passage de notre maternité, on fait presque, on va dire, une semaine de l'accouchement normal. Et donc, une maternité type 3, au niveau 3, ne devrait pas faire autant d'accouchements normaux. Elle devrait faire les 30 % du normal, et ça correspond aux gens qui habitent autour.

C'est-à-dire dans les quartiers qu'on a dans l'hôpital. Mais tout le reste, on devrait faire des césariennes, des grossesses à risque, des césariennes programmées et qu'on doit avoir. On l'a, parce que les grossesses à risque et les grossesses pathologiques, elles viennent chez nous.

Mais malheureusement, avec le flux des accouchements normaux, elles sont diluées, et le soin n'est pas de qualité, parce que les espaces qu'on leur offre, même si on essaie de leur laisser une partie du service où ils peuvent avoir un lit, alors que les accouchements normaux, je sais où on fait qu'ils naissent, c'est à l'heure qu'il faut qu'ils naissent. En tout cas, il y a quelque chose d'autre. Et heureusement, malgré tout ce que vous voyez et que vous n'aimez pas sûrement, moi aussi je n'aime pas, la mortalité maternelle et néonatale, déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de catastrophes.

Heureusement qu'on a encore un peu de chance d'avoir des résidents qui viennent, apprennent chez nous, ça nous aide à faire quand même l'activité calme. Mais logiquement, ça doit être autrement. Ça doit être les 48 heures qu'elle va passer dans la maternité, c'est un soutien.

Il y a des sages-femmes dans le service qui vont l'aider à faire sa toilette, ils vont lui ramener son repas, ils vont prendre soin de l'enfant, ils vont lui donner les premières médications, changer le premier bain. Tout ça doit se faire dans la maternité. C'est une occasion pour lui apprendre à faire ça, apprendre comment allaiter, et ça c'est toutes les positions, les soins d'hygiène, etc.

Lui apprendre à connaître, est-ce qu'il a bien mangé ou il a encore faim, à le changer et à lui donner son bain. Tout ça dans les maternités maternelles européennes, américaines ou nord-américaines, ça se passe dans la maternité. Et la personne qui ne sait pas faire ça, elle va l'apprendre dans la maternité avant la sortie.

Et donc avant la sortie, ou même au cours de l'hospitalisation, on devrait vérifier un certain nombre de choses, notamment certains signes fonctionnels, qui sont premièrement les lochis, et les lochis c'est vrai qu'on peut les voir, ce sera un signe physique, mais la patiente peut nous dire

la qualité des lochis. Les lochis c'est quoi ? C'est des petites sécrétions un peu saignantes, physiologiques du postpartum. Il y a des érythrocytes dans des globules rouges, des cellules épithéliales, du sang complet, des fragments de l'endomètre, et puis du mucus, bien évidemment, puisque maintenant l'appareil génital est ouvert au milieu extérieur, naturellement, mais normalement un col fermé, ça protège l'utérus.

Mais quand on a fait un accouchement, le col est ouvert, donc il y a sûrement des bactéries qui ont migré vers la cavité utérine. En général, il y a une odeur fade, mais non fétide, et quand la patiente vous dit que ça sent mauvais, il faut tirer le signal d'alarme, on est au début d'une infection. Les métrorragies peuvent être abondantes, elles sont non coagulées pendant les trois jours, puis elles vont diminuer, se fluidifier de plus en plus, c'est resanglante vers le huitième jour, puis elles vont devenir rosées, puis se tarir au fur et à mesure.

On peut parfois avoir ce qu'on appelle un petit retour de couche au bout des quinze jours, c'est-à-dire qu'elle va vous dire que ça a diminué, puis au quinzième j'ai eu encore un peu saignement. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, il faut juste que ça ne soit pas très abondant, parce qu'on peut voir que l'infection peut se manifester par de l'hémorragie, ça s'appelle les endométrites hémorragiques. Une endométrite, une métrorragie abondante, et là quand on va examiner, on peut trouver une fièvre, et quand on fait la CRP et la NFS, on trouve les signes d'infection.

Oui, et ce petit saignement, il peut parfois persister pendant plusieurs semaines jusqu'à le retour de couche pour la patiente qui n'allait pas, et puis il va se tarir au bout d'un moment pour la patiente qui allait. Puis à l'étranger, les adrénaline, ce sont ces douleurs type contraction intermittente qui sont exacerbées par les tétés. Puis il y a ce qu'on appelle la débâcle urinaire, c'est-à-dire que la vessie va changer de position puisqu'elle a été comprimée avec la grossesse, elle a été surélevée avec la présentation, et les femmes enceintes en général font de la polacurie, c'est-à-dire qu'elles vont aller uriner plusieurs fois, de petites quantités, et il y a un résidu qui reste en général.

Après la couche neuve, on voit ce qu'on appelle une débâcle urinaire, c'est-à-dire qu'elle va avoir envie d'uriner, parfois elle peut fuiter, elle peut avoir des fuites urinaires, et à l'inverse, des fois, on peut avoir même de la rétention aiguë d'urine. Si vous examinez cette patiente, et en fonction des semelles dont on vient de parler, on va voir objectivement cette involution utérine qui va descendre de la position abdominale à la position pelvienne, puis on peut aussi évaluer l'état du col, et puis évaluer l'état de la vulve, du vagin, du périnée. Il ne faut pas s'inquiéter qu'il soit un peu oedémato-équimotique juste après l'accouchement, et là on peut le traiter par un vessie de glace, surtout si on a fait une suture d'épiglottomie, et si on sent que ça a quand même saigné un petit peu, ou que ça risque de resaigner, on peut mettre un vessie de glace entre les cuisses de la patiente, et le froid va améliorer les moustades, et aussi va améliorer l'œdème, le gonflement.

Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire au cours de cette période du postpartum ? Déjà, surveiller, et

ça c'est surtout pendant la période de l'hospitalisation, mais sachez que dans d'autres pays, les femmes peuvent sortir à la maison et ils vont recevoir des visites de sages-femmes à la maison, et qui vont vérifier la normalité de tout ce que nous venons de dire, et là ils vont surveiller aussi l'état général, l'attention artérielle, la température, et l'absence d'hémorragie. L'attention artérielle est très importante à vérifier, même si la patiente a déjà accouché. D'un côté parce que ça peut faire le diagnostic du choc hémorragique, et s'il y a une hémorragie interne, surtout s'il y a une rupture utérine qui n'est pas diagnostiquée, ou une suture de césarienne qui n'est pas bien faite, la patiente ne peut pas saigner à l'extérieur, elle va saigner en intrapéritoneal.

Donc la surveillance de l'attention artérielle est un moyen très important pour surveiller l'état hémodynamique, ainsi que le poux bien évidemment, et puis la température, là aussi c'est important de la surveiller, parce qu'on a un risque infectieux clair en postpartum. C'est pour ça que l'accouchement doit se faire dans les conditions d'asepsie. Au pire des cas, si on ne peut pas le faire en aseptie, on doit le faire dans des conditions de propreté, c'est-à-dire avoir des gants propres, avoir des champs propres, des serviettes propres.

Ça c'est dans le cas où ça peut vous arriver d'accoucher à une personne en dehors du milieu hospitalier, il faut s'assurer, ça peut être des serviettes propres, ça peut être nettoyé avec du savon, le périnée par exemple, si vous n'avez pas de la betadine ou là un antiseptique, etc. Et donc pour assurer au moins une propreté minimale, parce que les risques de l'infection perpérale, c'est-à-dire l'infection du postpartum, de l'utérus, les graves parfois ça peut tourner très mal, on peut passer très vite vers le sepsis. D'abord il faut la prévenir, et donc c'est accoucher ou faire la césarienne en aseptie.

Pire des cas, quand les conditions sont extrêmement rapides, il faut quand même préserver la propreté, laver de l'eau, etc. Même après l'accouchement, il faut savoir bien laver le périnée, etc. Et enfin, qu'est-ce que j'allais dire, la surveillance, la moindre fièvre du postpartum, c'est une infection perpérale qu'il faut traiter sérieusement.

Puis on peut conseiller le lever précoce, parce qu'il y a un risque de thromboembolique. Pour l'alimentation, une alimentation équilibrée, et continuer la supplémentation en fer. Vous avez sûrement, je pense qu'on en a parlé, vous et moi, pour la supplémentation en fer au cours de la grossesse, qu'elle devrait se faire de façon systématique, mais que vous devez prolonger en postpartum, surtout si la patiente est allaitante.

Parce que l'allaitement, ça va puiser aussi le fer de l'organisme de la patiente, donc il ne faut pas arrêter. C'est ce que je conseille à mes patientes, continuez votre supplémentation préventive jusqu'à la fin de l'allaitement, ça ne va absolument pas vous faire du mal. Et aussi pour lutter contre l'anémie, parce que même une patiente opérée césarisée, l'anémie est un facteur de quoi ? De mauvaise cicatrisation.

Et donc la cicatrisation au niveau utérin va être de mauvaise qualité. Si elle est de mauvaise

qualité, il y a un risque plus tard de faire une rupture ou une déhiscence de la cicatrice. Encourager l'allaitement, ça doit être l'une des priorités d'un médecin généraliste dans un quartier ou quand il a des patientes qu'il suit en consultation prénatale, ou même autour de vous, dans votre famille.

Il faut savoir encourager l'allaitement maternel, parce qu'il a toutes les raisons positives. Je pense qu'on va en parler vers la fin, d'être encouragé. Après, on peut traiter les petits problèmes, comme par exemple quand il y a de la rétention aiguë d'urine.

Sachez que ce n'est pas rare, ça ne doit pas inquiéter énormément. Il y a beaucoup de femmes qui, après l'accouchement, peuvent faire une rétention d'origine nerveuse, réflexe. Ils vont faire de la rétention aiguë d'urine.

Ce qu'on fait, c'est qu'on va les sonder. On va laisser le sondage un petit moment. Parfois, ça peut aller jusqu'à 24 heures.

Puis, on va les clamber au fur et à mesure, clamber et lâcher, clamber et lâcher. Par la suite, ça va s'améliorer et le réflexe va revenir. Quand il y a de l'hypogalaxie, c'est-à-dire un manque de la production du lait, on peut conseiller une alimentation qui permet de le stimuler.

Normalement, dans notre culture, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Manger bien pour faire du lait. Manger bien, c'est manger le pain, manger le rissia, les choses comme ça. Mais ce qu'il faut conseiller à votre patient, c'est que c'est les liquides qui permettent d'avoir le lait.

Elle peut manger autant de rissia qu'elle veut si on ne prend pas une bonne bouteille d'eau de un litre et demi en journée, c'est-à-dire minimum trois litres par jour. À côté, elle doit faire des boissons chaudes, les tisanes, les bouillons, les soupes. C'est ça qui donne le lait.

Bien évidemment, ici, c'est noté le fer, mais aussi les poissons, les sardines. Ça, pour moi, quand vous aurez votre activité cabinée, par exemple, il faut faire l'effort d'aller voir un peu de nutrition. En général, la plupart des généralistes font des formations de nutrition.

Quand ils s'installent en privé, parce que ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Il y a des techniques, rien qu'avec l'alimentation, pour redémarrer une lactation qui diminue. À la sortie de la maternité, on doit s'assurer que la patiente a des constantes normales, que ses mollesons sont libres.

Le toucher vaginal à la sortie, il est presque obligatoire entre nous. Surtout pour ça. Ça, c'est ce qui est grave.

Tout le reste, c'est rattrapable, il n'y a pas de souci. Là, c'est écrit qu'on va évaluer le tonus musculaire et vérifier l'absence de saignement. L'absence de saignement, on peut le faire sans toucher.

Le tonus musculaire, on n'a pas besoin de le faire tout de suite à la maternité. On va le faire après la consultation post-natale. Surtout si la patiente a une épisiotomie, elle a des sutures au niveau du sang vagin.

Lui demander de se contracter, ce n'est pas très très. Je ne suis pas très d'accord. Mais surtout, c'est un moyen d'éviter des accidents qui peuvent survenir après la suture d'une épisiotomie, par exemple.

On met des compresses ou des tampons pour arrêter le saignement. Et des fois, ça arrive que la patiente revient plus tard avec des odeurs très fétides, très mauvaises. Et quand on réexamine, on peut trouver soit une mèche, soit une compresse qui a été oubliée avant la sortie.

Ce n'est pas fréquent et ce n'est pas acceptable. Mais ce toucher de sortie permet quand même de rattraper des situations comme ça. Puis, vérifier toujours que le globe est bon.

Et puis, on va examiner les seins pour voir que la montée des doses est bonne et qu'il n'y a pas de problème. Alors, les consignes à la sortie, c'est la même chose. D'accord ? On va voir le fond utérin, le caractère des loçi.

On va expliquer les soins de l'épisiotomie, d'accord ? Qui doit être tout simplement une antisepsie correcte. C'est-à-dire qu'elle va utiliser un antiseptique deux ou trois fois par jour. On peut utiliser aussi un produit cicatrisant.

Et là, il y a beaucoup de bons produits cicatrisants qui permettent d'améliorer la cicatrisation. Et je ne sais pas si vous l'avez appris avec les chirurgies plastiques ou les maxillofaciales, c'est que la plaie doit guérir en environnement gras, pas asséché. D'accord ? Voilà.

Et donc, on peut prescrire des crèmes cicatrisantes qui vont garder justement la surface de la cicatrice grasse. Surtout la cicatrice cutanée. Pour les gens qui ont déjà fait ou qui ont déjà vu faire des épisiotomies, il y a une cicatrice muqueuse jusqu'au niveau du limaine.

Et puis, il y a la cicatrice cutanée qui est vers l'extérieur. Bien évidemment, entre les deux, il y a la suture musculaire, mais qui ne vont plus être visibles après. Et donc, surtout pour cette partie, la muqueuse est humide par définition.

Mais la partie cutanée peut s'assécher. Et si elle s'assèche, ça va tirer sur les fils et ça, ça va faire de la mauvaise cicatrisation. Et quand on utilise un fil résorbable, quand il est sec, il ne va plus se résorber parce qu'il se résorbe dans un milieu humide.

C'est ce qui est à l'intérieur de l'abdomen ou à l'intérieur du vagin, etc. Et donc, il faut penser à expliquer à la patiente qu'il faut quand même garder cette zone-là grâce à cause ou par le biais d'une crème. Et bien sûr, expliquer quels sont les signes de l'infection pour que si jamais ça survient, la patiente revienne.

Et puis, les soins de la plaie et de la césariée. Bien évidemment, on peut prendre le temps, et ça c'est en général le travail des sages-femmes, mais pas des médecins, de prendre le temps d'expliquer à la patiente quelle nutrition elle va prendre, quel sport elle peut faire, à quel moment, son activité sexuelle, quand est-ce qu'elle va commencer, et puis sa contraception. En général, ça c'est le travail des sages-femmes, mais sincèrement.

Les sages-femmes, c'est elles qui ont le temps qui doit être consacré à la patiente, d'accord ? Et par défaut, on va dire, ou si dans votre cabinet la patiente ne sait pas ce qu'elle doit faire, vous pouvez expliquer ça. Pour la rééducation uropérinéale, en fait, pendant longtemps, on disait que c'est une kiné qui est systématique pour prévenir le prolapsus génital et l'incontinence urinaire. Je veux que vous reteniez, je vais le changer sur la plaque, d'accord ? Pour vous dire que c'est un cours qui a été préparé par le professeur Esmak Odol, qui enseignait normalement avec nous et qui n'est plus dans la faculté.

Je vous expliquais aussi que je n'ai pas pu mettre à jour mes diapos, mais on va changer ces diapos. La littérature est, après que cette kiné a été faite systématiquement pendant longtemps à toutes les femmes, il paraît que ça ne protège pas obligatoirement de la survenue d'un prolapsus ou d'incontinence urinaire à un âge plus avancé, d'accord ? Et que cette kiné va être prescrite précisément à des patients chez qui il y a un besoin, c'est-à-dire qui ont eu une déchéance périnéale importante, qui, quand on fait l'examen à six semaines, on trouve que le tonus est vraiment très lâche, ou bien qui garde une incontinence urinaire pendant longtemps après l'accouchement. Parce qu'une petite incontinence urinaire dans les premières semaines, ce n'est pas grave, ça peut revenir à la normale.

Mais qui garde ça pendant un peu plus longtemps, jusqu'à revenir à la sixième semaine, là on va prescrire la kiné uropérinéale. Et en général, ça ne doit pas commencer avant six semaines, parce que ça n'a pas encore cicatrisé. Les muscles ont besoin de cicatriser, parce que même s'ils ne sont pas rompus, avec la dilatation au passage de la présentation, il y a des fibres qui vont se rompre, donc il faut du temps pour que ça cicatrise.

Et on peut prescrire à peu près dix séances. En fait, comment ça se passe, c'est que la patiente va partir chez une kiné, et la kiné fait son évaluation du tonus musculaire aussi, et parfois ils vont utiliser des sondes qui peuvent être introduites au niveau du vagin, qui ont deux intérêts. Le premier, ils ont un feedback, c'est-à-dire quand on dit à la patiente de contracter le périnée, il y a une courbe qui s'affiche sur un moniteur, ça permet à la patiente de voir son mouvement, est-ce qu'il est efficace ou pas.

Parce que reprendre la sensation normale du périnée, ce n'est pas facile pour une femme qui a accouché. C'est complètement dilaté, tous les repères de l'espace et proprioceptifs ont changé. Pour que dans sa tête, elle retrouve les sensations pour pouvoir contracter le périnée, et en général, c'est la contraction qui nous permet d'arrêter la mixtion, il y a la contraction du muscle releveur de l'anus.

Quand la patiente n'arrive pas à la retrouver, on essaie de lui dire d'imaginer que la mixtion est en cours et qu'elle est en train de l'arrêter. Elle peut le faire toute seule, et c'est à ce moment-là qu'elle va reprendre conscience de son périnée. Alors, ce centre va lui permettre de voir l'intensité de sa contraction, et en général, elle va la voir avancer au fur et à mesure que le travail est fait.

Et aussi, ça peut être utilisé pour faire de l'électro-stimulation de ce muscle-là. La kiné, l'équidéro, l'électro-stimulation, les muscles somatiques. À la sortie aussi, on va parler de la contraception.

On va expliquer que l'ovulation peut reprendre dès le premier mois, et qu'en général, les rapports sexuels peuvent reprendre dès l'arrêt des lochis ou des saignements. Et donc, c'est pour ça que les patientes devraient commencer la contraception avant le début ou la reprise des rapports sexuels. Parce que si elle ne prend rien jusqu'à un mois, jusqu'à 40 jours, et qu'elle commence une activité sexuelle, elle peut déjà avoir ovulé et avoir une grossesse.

Et ça, c'est arrivé. Dans votre famille, il y a sûrement des enfants qui ont moins d'un an d'intervalle. C'est ça, c'est les grossesses de la période du postpartum.

Et c'est pour ça que les patientes devraient commencer la contraception avant la reprise de l'activité sexuelle. Quelle contraception on va décrire ? En général, c'est les micro-progestatifs pour les patientes qui allaitent, ou quand on a une contre-indication oestroprogestative, notamment l'hypertension artérielle, le diabète ou le risque thrombo-ombolique. Et ceci pour les patientes qui ne veulent pas allaiter ou qui ont une contre-indication à l'allaitement.

Parce que ça existe les contre-indications à l'allaitement, oui ou non ? Le VIH, d'abord, c'est une contre-indication absolue. C'est une contre-indication quand la patiente a encore une charge virale détectable. Ça peut être des cardiopathies.

Une patiente qui a une cardiopathie, un stade de NIA3, elle ne peut pas allaiter. On va devoir leur mettre des oestroprogestatifs. Walaikine, il a un problème.

On ne peut pas mettre des oestroprogestatifs, donc on va mettre un micro-progestatif. Dès la sortie de la maternité ou le 21e jour sans interruption entre les plaquettes ? En fait, il faut éviter ça. On va le faire dès le 21e jour à l'âge.

Même si c'est des progestatifs purs, ils ont quand même un petit risque thrombotique. Donc, on doit le garder en tête. D'ailleurs, si on a une patiente qui a une thrombophilie, on la descend dans des antico-antiphospholipides, c'est-à-dire qu'elle a un risque inné de faire des thromboses veineuses et des thromboses artérielles.

Alors, même les progestatifs seulement à l'intérieur du cheveu. Contre-indiqué. Si on va dans les contre-indications absolues d'elle, les micro-progestatifs, c'est les antécédents personnels de maladies thrombotiques.

Et donc, il faut faire attention pour ne pas surajouter le risque du postpartum immédiat, le risque d'elle, la pilule, même si elle est micro-progestative. Et donc, on commence en général vers la 21^e semaine. Si vous allez dans les recommandations de l'OMS, vous pouvez trouver qu'ils vont prolonger ça jusqu'à le premier mois.

Mais si on voit les recommandations européennes, 21 jours, ça passe. Pour les micro-progestatifs, c'est important la prise à heure fixe. Pourquoi ? Parce que si jamais on oublie, l'oubli va parfois donner des saignements anarchiques.

Ça s'appelle des spotting. Et donc, les patients devraient savoir qu'il faut prendre cette pilule à heure fixe et que c'est continu. Les oestroprogestatifs, si on doit les commencer, on va les commencer un peu plus tard parce que là encore, il y a le risque thrombotique encore plus important avec les oestroprogestatifs.

Et puis, si la patiente ne l'aide pas, elle peut reprendre la même pilule qu'elle prenait auparavant. Il n'y a absolument aucune particularité dans ce sens-là. Si la patiente ne veut pas de contraception hormonale ou elle a une contre-indication médicale à la contraception hormonale, on peut lui proposer un stérilet ou un dispositif intra-utérin au cuivre.

Et on a vu qu'on peut le mettre en place soit immédiatement, soit après un mois ou après, de un mois à trois mois. Sinon, les autres méthodes contraceptives, notamment les méthodes locales, préservatives, spermicides, etc., il faut savoir que ce sont des moyens qui sont très peu efficaces. C'est-à-dire qu'il y a un risque très élevé de grossesse non planifiée en utilisant ces moyens-là.

Donc, à date, je veux que vous gardiez en tête ça à chaque fois que vous avez. Il y a des couples que ça ne dérange pas d'avoir une grossesse immédiatement après. C'est leur choix.

Mais le problème, il faut les convaincre qu'il y a la santé de la maman qui est en jeu. Il faut au moins deux ans d'intervalle parce qu'il faut que la patiente finisse son allaitement. Elle est loula.

Pour que le nourrisson profite de son allaitement et surtout de l'affection de sa maman, pendant les deux premières années, on me dit « elle est normale ». Mais aussi parce que faire des grossesses HAKDA itératives et rapprochées, ça va consommer complètement les réserves de la patiente. Toutes les réserves, que ce soit le fer, la vitamine D, toutes les autres vitamines, l'os, c'est-à-dire le calcium, d'ailleurs. C'est des femmes qui vont avoir des douleurs osseuses, qui vont avoir des caries dentaires rapidement, vont perdre leurs dents, leurs cheveux, etc.

Donc on devrait les convaincre de faire quand même un espacement de naissance. Ça s'appelle d'au moins deux ans pour l'intérêt de la santé maternelle et infantile, c'est-à-dire du premier. Le message que je voulais vous dire par rapport aux méthodes, par exemple, locales, c'est qu'à chaque fois, en dehors de la situation du postpartum, que vous avez une condition médicale qui, par exemple, contre-indique la grossesse, c'est-à-dire où le fait de tomber enceinte va créer un

risque important sur la santé de la maman.

Les exemples plus simples, c'est un diabète mal équilibré, c'est une cardiopathie, une maladie de système non, qui n'est pas en rémission, par exemple, et donc cette femme ne doit pas tomber enceinte, maintenant en tout cas, ou là, jamais. Alors ces moyens-là, ils ne sont pas du tout efficaces et vous ne devez pas compter sur ça et vous ne devez pas encourager les patients à les utiliser. Donc, soit la contraception hormonale est autorisée et vous allez l'utiliser, soit elle n'est pas autorisée, vous avez la contraception non-hormonale type dispositif intra-utérin.

Ça va vraiment être catastrophique pour la santé de la maman si elle tombe enceinte encore une fois. Sinon, quand on soulève la situation, il y a la stérilisation, c'est-à-dire si j'ai une patiente qui a, on va dire, par exemple, ça nous arrive maintenant récemment parce qu'on a beaucoup de patients jeunes qui font de la pathologie cancéreuse et qui, soit elles ont de la chance, elles ont deux, trois enfants avant, soit elles n'ont pas de chance. En tout cas, quand la patiente a déjà un nombre suffisant d'enfants et que la pathologie qu'elle a est aggravée par la grossesse, le cancer de sein est aggravé par la grossesse, surtout dans les deux premières années, il arrive que l'équipe médicale puisse proposer une stérilisation, une assistance rénale chronique sous dialyse, par exemple.

Elle a déjà quatre enfants, on va dire. On peut lui proposer une ligature, donc section des trompes, c'est une stérilisation et ça, ça peut être fait au cours de son hospitalisation à la maternité, soit au cours de la césarienne si c'est une césarienne, soit juste après l'accouchement avec une petite stéréoscopie, on peut faire cette ligature. Voilà, c'est pour les grossesses pathologiques.

Alors, ultérieurement, si on va semaine par semaine, ce n'est pas possible parce que nos patientes, malheureusement, elles vont dans les montagnes et on ne les voit même pas à six semaines. Mais bon, logiquement, on devrait pouvoir communiquer avec la patiente, même si elle est à la maison, au téléphone, par la télémedecine. Maintenant, elle peut appeler sa sage-femme, elle lui pose des questions et si jamais il y a un problème, on va lui demander de venir à l'hôpital.

On ne fait pas de consultation toutes les semaines, mais en général, il faut qu'il y ait une équipe de sages-femmes qui suit le poste partant. Et quand il y a une pathologie ou une anomalie, elle va mettre le médecin sur l'affaire. Donc, ça, c'est un luxe que certains pays se permettent de garder les patientes en hospitalier et ça, je sais que ça existe parce qu'on a des amis, des collègues qui ont accouché dans d'autres pays et qui effectivement restent à la clinique ou à l'hôpital pendant une semaine.

Et il y a ceux qui sont visités à la maison, comme je vous l'ai dit. Eh bien, l'examen va faire le tour de tout ce que nous venons de dire là maintenant. Qu'est-ce qui s'ajoute à ça? C'est l'examen des seins.

Pourquoi? Parce qu'une patiente allaitante, c'est une patiente qui risque de faire beaucoup de complications sur l'allaitement. On va le voir à la fin du chapitre. Mais aussi, pour les patientes qui sont sous allaitement artificiel, on a besoin de faire ce qu'on a. Soit qu'elle n'a pas de lait et c'est pour ça qu'elle a choisi ou la menthe ne s'est pas bien faite.

Donc, il y a un tarissement de la menthe laiteuse. Donc, il n'y a pas de problème. Mais chez les patientes qui ont une contre-indication à l'allaitement maternel, il faut faire ce qu'on appelle un blocage de la menthe laiteuse.

Autrefois, on utilisait la bromocryptine, qui est le parlot d'elle, et qui était la molécule référence. Mais malheureusement, elle a été retirée du marché. Donc, ce n'est plus produit.

Et celle-là, on l'utilisait en progressif. C'est-à-dire, on commençait par un demi-comprimé, puis un comprimé, puis deux par jour, jusqu'à arriver à trois par jour. Et c'est ce qui va permettre d'arrêter l'allaitement.

Maintenant, ce qu'on utilise, c'est la cabergoline, qui est d'Ocinex, et qui est un produit qui existe dans le marché. En général, c'est une boîte où il y a un seul comprimé, et c'est une prise unique. Donc, elle peut la prendre immédiatement après l'accouchement, et ça va permettre d'arrêter l'allaitement.

Si ça ne marche pas, on peut reprendre une deuxième après une semaine. C'est le même médicament ou molécule qui est utilisé pour les hyperprolactinémies, les adénomes aprolactines, les adénomes épophysales. Comment gérer la césarienne et tout? C'est comme toute plaie chirurgicale.

Sûrement, vous êtes passé par les services de chirurgie, vous savez soigner des cicatrices, donc il faut la surveillance de l'inflammation, de la supéation, de la non-cicatrisation, de la collection en dessous, etc. Et puis, pour le périnée, c'est la même chose, pour la surveillance de la cicatrice d'épisutomie ou de déchirure. Tout ça devrait être réalisable par la patiente elle-même.

Sinon, comme je vous ai dit, les sages-femmes qui font des visites à domicile aux patientes, elles vont surveiller ces éléments de cicatrisation. Ici, qu'est-ce qui est écrit? Le fil résorbable en points séparés ou surjet intradermique. Alors, quand vous faites des points ou un surjet intradermique, le fil est dans le derme.

En général, vous n'allez rien retirer, il va diffuser. Mais quand vous faites des points séparés, et je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait des épisutomies au service, vous êtes inquiets, vous ne l'en faites pas. Merci, c'est épis.

Alors, normalement, le point cutané, on peut faire un surjet cutané. Et là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le fil peut s'assécher et ça ne va pas aller. Et puis, il faut expliquer la toilette quotidienne.

Le séchage, ce n'est plus autant qu'avant. On le conseillait avant. Maintenant, comme j'ai dit, les plasticiens et les gens qui ont étudié la cicatrisation cutanée, il ne faut qu'il n'y ait pas de tension, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle reste dans un milieu gras.

Les membres inférieurs, c'est-à-dire qu'on va regarder s'il y a des signes tout simplement de phlébides. Et ça, vous le connaissez, je pense, parce que vous avez déjà étudié les thrombophlébides. Les membres inférieurs, c'est simple.

Le hormens, les indurations trajévénueuses pour les veines superficielles, puis la douleur, la rougeur, donc le mollet et la disparition du ballonnement du mollet. Parfois, il y a une dissoussesse entre le pot et la température. Et bien évidemment, il y a des moyens de prévention.

Premièrement, les anticoagulants à base de molécules. Comme j'ai expliqué, pour la césarienne ou quand il y a des facteurs de risques rajoutés, la levée précoce, même pour les patientes opérées, peuvent se lever le même jour, marcher. Et puis surtout, le port des bas de contention.

Sachez que dans les pays qui se permettent d'acheter les bas de contention pour toutes leurs patientes, les bas de contention, ils sont mis en place au bloc opératoire juste avant la césarienne. Donc, à l'installation de la patiente, on lui met ses bas de contention, à l'aide, on met les champs d'IANA, à l'aide, on fait la césarienne d'IANA et il paraît que ça, ça fait partie des moyens de prévention de la maladie thromboembolique. Alors, quelles sont les complications? On a sûrement parlé de beaucoup de choses là-bas, donc on va répéter un certain nombre de choses.

Le plus important, c'est l'infection et ça s'appelle l'infection puerpérale, l'hémorragie, qui peut être aussi secondaire à l'infection, complications de l'allaitement, l'amenorrhée, et on a expliqué que l'amenorrhée, c'est physiologique en général, sauf si la patiente n'allait pas, la maladie thromboembolique et les complications psychologiques. Donc, si on veut parler de l'infection puerpérale, la règle, comme je viens de vous dire, chez la femme au postpartum, c'est que toute fièvre au cours de la période du postpartum, c'est une infection puerpérale jusqu'à preuve du contraire. Et quand on dit infection puerpérale, ce n'est pas une petite vaginite ou un cervicide, c'est de l'endométrite, d'accord? C'est une endométrite du postpartum qui peut se compliquer par une salpagite bilatérale, par des abcès tubo-ovariens ou carrément par une pelvipéritonite.

Et la pelvipéritonite, si elle n'est pas traitée à temps, on finira de dire que c'est... La pelvipéritonite, c'est localisé dans le pelvis, c'est toujours localisé et on peut même traiter médicalement. Mais quand ça diffuse au reste de l'abdomen, on est dans la pelvipéritonite généralisée et là il n'y a que le traitement chirurgical qui permet de faire. Au-delà de cette étape aussi, elle peut se compliquer d'un état de sepsis grave, d'accord? Donc, il faut faire attention, toute fièvre égale infection jusqu'à preuve du contraire.

La fièvre qui peut survenir et qui n'est pas d'origine infectieuse et puerpérale, c'est la menthéliteuse. Et là, c'est une petite fièvre, c'est un petit fibricule, d'accord, qui peut survenir à J2, J3 et en général c'est passager, d'accord? Ça ne va pas dépasser 38,5 et ça va passer rapidement. Alors que l'infection corporelle, c'est une fièvre patente, c'est-à-dire ça va être du 39, 39,5, du 40, elle va s'accompagner de frissons, elle va s'accompagner de douleurs pelviennes et elle va donner un signe d'appel à la région pelvienne.

Quand est-ce qu'on va avoir un risque supplémentaire d'avoir de l'infection puerpérale? C'est quand l'asepsie n'est pas respectée et là parfois c'est les accouchements à domicile mais aussi dans les accouchements où il n'y a pas respect de l'asepsie, d'accord? Ça peut arriver chez nous aussi. Les mauvaises hygiènes, c'est-à-dire ne pas savoir respecter cette asepsie-là. Présence d'une infection antérieure, c'est-à-dire la rupture prématurée des membranes, l'infection génitale avant l'accouchement ou l'infection urinaire avant l'accouchement ou carrément les situations de chorio-amnionite.

C'est-à-dire une patiente qui a fait une RPM de plus de 6 heures ou là de plus de 12 heures, elle a un risque d'infection. Qu'est-ce que ça veut dire pour le postpartum immédiat? Oui, il faut la mettre sous antibiotique après l'accouchement, c'est obligatoire. Plus encore, une patiente qui a fait, on va dire, un menace d'accouchement prématuré parce qu'elle avait une infection urinaire.

On a fait le diagnostic, il faut la mettre sous antibiotique, adaptée. Maintenant une patiente qui a présenté de la fièvre au cours du travail. Avec les autres signes de la chorio-amnionite qui sont l'attaqué cardiaque maternel, l'hypersensibilité abdominale, mais ça peut aussi être l'attaqué cardiaque fatal ou la souffrance fatale.

Cette patiente-là, d'emblée, on la met sous antibiotique au cours du travail. Mais en général, on ne va pas la mettre sous flagelle ni sous ampicilline. Donc si cette patiente a de la fièvre au cours du travail, en post-accouchement, on ne va pas la traiter par une antibiotérapie simple, mais on va la traiter avec une triple antibiotérapie, ou une antibiotérapie à large spectre.

Soit du stéfalosporine troisième génération plus la gentamicine, soit une amoxicilline plus flagelle plus gentamicine, soit une amoxicilline protégée plus gentamicine. C'est-à-dire qu'on va cibler les aérobie et les anaérobies. Puis, quand on fait un travail prolongé, les manœuvres endo-utérines, la délivrance artificielle, la révision utérine, et là, il faut mettre une antidiéprophylaxie.

La césarienne, quand elle est faite dans des conditions programmées, c'est-à-dire en extrême urgence, ce n'est pas un facteur de risque important. Mais si elle est faite en urgence, c'est-à-dire ça peut être n'importe où, elle peut avoir la RPM, elle a la souffrance, ça se fait très vite, c'est un facteur de risque d'infection. On va avancer un peu vite pour gagner du temps, parce qu'on a perdu la première partie.

Les germes, c'est beaucoup de germes aérobiques qui se trouvent au niveau de la région urogénitale, donc tout ce que vous voulez, strepto, staph, etc. Les grammes négatifs comme les chéchéakolis, surtout, mais on peut avoir du klebsiella et du proteïus, parce que l'accouchement qui se fait dans un milieu hospitalier, le klebsiella, c'est un germe nosocomial et il peut exister, donc il faut toujours le garder en tête. Puis, tous les anaérobistes ont possible ou pas cible de participer à cette infection, et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une antibiothérapie qui couvre les anaérobistes.

Donc, soit de l'amoxicilline protégée, comme j'ai dit, c'est phallosporine plus jantamicine, soit une amoxicilline, jantamicine et metronidazole. L'endométrite, c'est ce que je vous ai expliqué, elle est fréquente et grave, et puis si elle n'est pas traitée, ça va devenir hyper grave. Syndrome fébrile, la frisson, douleurs péluènes, les louches qui sont abondantes et surtout fétiches, c'est-à-dire qui sont mauvaises.

Quand on va examiner, on va trouver que c'est un utérus qui n'est pas bien involué, qui est douloureux et surtout qui est mou, parce que si vous avez palpé le globe de sécurité, si vous avez palpé le globe de sécurité, c'est dur. Donc un utérus infecté, c'est un utérus qui est plutôt mou, d'accord? Et puis quand vous faites votre toucher, vous mobilisez l'utérus, ça fait très mal, c'est la douleur à la mobilisation utérique. Il y a les formes les plus graves, c'est la pelvipéritonite, c'est le piosalpingue, c'est-à-dire des collections supéaies à l'intérieur du pelvis, soit dans la trempe, et c'est le piosalpingue, soit les abcétubo-ovariens, c'est-à-dire dans l'ovaire ou à côté de l'ovaire, et ça peut aussi être dans les paramètres, et ça c'est encore plus dangereux, c'est les fléguelements du légume en large, d'accord? C'est la même chose, sauf qu'ici il y a encore la participation péritoniale, c'est-à-dire vous allez avoir les vomissements, le diarrhée parfois, parfois arrêt des matières et des gaz, c'est-à-dire que c'est un tableau qui commence à s'approcher de la péritonite, et vous allez trouver de la défense, soit qu'elle est localisée dans le pelvis, et on est encore dans la péritonite, mais quand ça se généralise, ça vous connaissez faire le diagnostic de la péritonite généralisée, et là c'est une chirurgie en urgence, d'accord? Quand il y a le retard, c'est ce qu'on vient de dire, péritonite généralisée, thrombophlébite pélvienne supéaie, ça existe aussi, c'est-à-dire dans la situation du sepsis, avec l'hypercoagulabilité, on peut avoir des thromboses et qui sont en plus infectées, et puis la septicémie.

Et là, la mortalité maternelle peut augmenter sa fréquence. Comment traiter l'antibiothérapie en urgence? Par intérêts à large spectre, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors soit amoxycine d'acide clave, clin d'amycine, jeûne d'amycine, en tout cas il faut toujours garder en tête de couvrir l'ensemble. Triple association, amoxycine, jeûne d'amycine, métronidazole, sinon je peux utiliser céphalosporine troisième génération, plus la jeûne d'amycine.

Les utérotoniques, pourquoi? Parce que l'ocytocine va créer une contraction, et il va chasser toutes les sécrétions infectées de l'intérieur, ça améliore les choses. Mais dès qu'on passe à la péritonite ou à la supération, c'est-à-dire on fait l'écho et on trouve des abcès, des gros abcès, il

faut que ce soit quand même supérieur à six centimètres, on doit ouvrir pour le drainage. Prévention aseptique et antibioprophylaxie quand il le faut, dans les facteurs de risque, et puis le respect des règles de l'antibiothérapie dans les interventions obstétriques, la révision utérine, la césarie, un carton de la prophylaxie, etc.

Donc ça c'était la complication lourde liée à l'infection puerpérale. Puis la deuxième complication qui n'est pas très grave ici, pourquoi? Parce que souvent l'hémorragie grave c'est dans les 24 heures, c'est la période du postpartum immédiat. Ça m'a fait le risque hémorragique lourd, le risque thrombotique et le risque d'infection.

Maintenant on va le mettre en deuxième position. Donc c'est rare qu'on ait des retours de couche hémorragiques, mais s'il y a un retour de couche, c'est-à-dire un saignement, un chuiège d'un saignement, mais qui est abondant, la première diagnostique à évoquer c'est encore l'infection, qui va donner une forme hémorragique. Et ça peut se faire à cause d'une rétention placentaire, c'est-à-dire qu'il y a un petit morceau de placenta qui n'est pas éjecté, qui reste à l'intérieur, et aussi à cause de l'insuffisance oestrogénique, c'est-à-dire que les oestrogènes quand ils augmentent le taux, le début du cycle, c'est ce qui arrête les règles.

Quand on a la période de saignement, c'est-à-dire les menstruations, pourquoi est-ce qu'il y a des menstruations ? Si on a un taux d'oestrogène, les follicules qui produisent les oestrogènes ou qui trahissent l'oestrogène, à un certain moment ils vont bloquer le saignement. D'ailleurs quand il y a des hémorragies, c'est-à-dire des saignements de règles abondantes, parfois on peut donner des doses élevées d'oestrogènes pour éviter les hémorragies. Et donc on va traiter par les antibiotiques, par les hémostatiques, et parfois par un cure-tâche digital ou instrumental quand on a un problème de rétention placentaire.

Autre possibilité de complication, c'est les aménorrhées. On a vu qu'une patiente allaitante peut rester aménorrhée et qu'elle a des cellules allaitantes. Ça ne nous dérange absolument pas.

C'est la patiente qui n'est pas allaitante. Si jamais elle n'a pas de retour de couche fluocytienne au-delà de trois mois, là on va se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui peut se passer, c'est qu'elle a une nouvelle grossesse et donc il faut éliminer la grossesse en premier.

Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'elle a une aménorrhée ovulatoire, c'est-à-dire qu'elle a fait son ovulation, mais qu'il y a un problème sur l'utérus parce qu'il y a une synéchie. Une synéchie utérine, c'est un accolement des faces de l'endomètre. Et ça, ça peut survenir après la césarienne ou après l'incrustage, ou après une révision utérine, c'est-à-dire un geste endo-utérin.

Soit une aménorrhée anovulatoire, c'est-à-dire d'origine centrale, et là ça peut être aussi hypophysaire et elle peut faire une hyperprolaxie nématée. Sinon, ça peut être aussi un problème ovarien, si jamais elle est un peu avancée dans l'âge, ça peut être une insuffisance ovarienne. Et puis les aménorrhées psychogènes, ça existe.

Une patiente qui est dans un état dépressif profond, elle est sous traitement antidépresseur aussi, les traitements antidépresseurs, ça peut donner une hyperprolaxie néquée et ça peut donner l'aménorrhée. Et puis il y a enfin le syndrome de Sheehan qu'on ne voit presque plus, parce que c'est une complication de l'hémorragie grave du postpartum. La patiente était dans un état de choc tellement important qu'il y a eu une petite ischémie au niveau de son hypophyse et qui va retentir sur toutes les lignées, thyroïdienne, ovarienne, surrénalienne.

Ça c'est le syndrome de Sheehan. Et donc il n'y aura pas uniquement l'aménorrhée, il y a aussi l'hypothyroïdie, il va y avoir aussi l'hypocortisomie. Maladie thrombotique, vous avez bien compris le risque, le risque qui est dû au fait que la femme est enceinte, qu'il y a des modifications physiologiques, qu'il y a l'immobilisation et tout le reste, et que cliniquement ça va se manifester comme toutes les thromboses veineuses profondes que vous avez déjà étudiées, petite fièvre et puis un gros membre inférieur qu'on va examiner, on va trouver les signes de la thrombose veineuse profonde.

Donc on doit examiner, bien sûr, on doit confirmer par l'échographie ou l'angiographie et puis on va traiter en fonction des protocoles que les cardiologues maîtrisent bien. Déjà, hospitalisation et par endothérapie, puis on va passer aux affects après et le traitement préventif, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, levées précoces, les bas de contention, mobilisation, épargne d'apport moléculaire. Sachez qu'un bon nombre de mortalités maternelles survient à cause de l'embolie pulmonaire.

Ce n'est pas du tout rare. Donc il faut prévenir la mort des thrombes emboliques, il faut diagnostiquer la thrombose veineuse profonde rapidement et la traiter rapidement parce que sinon ça peut se compliquer. Et puis une femme ou une patiente qui présente un problème comme ça, ça va retentir sur son mode de contraception.

C'est clair. Donc toute la contraception oestroprogestative va être contre-indiquée absolument. Et la patiente a une maladie thromboembolique postpartum, mais elle ne pourra pas être traitée d'oestroprogestative parce qu'elle va thromboser.

Sinon ce sont des patientes aussi qui peuvent avoir des risques de, comme j'ai dit tout à l'heure, de thrombophilie et donc il faut reprendre un interrogatoire, faire tout ce qu'il faut pour chercher ce terrain-là. Sur répétition, non ? Enfin, les complications psychologiques, ça on en a parlé tout à l'heure. Ce qui est recommandé maintenant, c'est de les dépister et c'est à ça que ça sert la consultation postnatale de six semaines qui permet de discuter avec la patiente, de voir si elle a bien réussi ses premières étapes d'adaptation psychologique et qu'elle est dans la position d'acceptation et d'attachement avec son nouveau-né.

Sinon, il faut un soutien psychologique et parfois il y a la vraie dépression. Il y a la déprime ou le baby blues, mais il y a la vraie dépression quand on a besoin de mettre ce traitement antidépresseur, par exemple, et même parfois on peut avoir des états psychotiques et bon, ça peut

tomber des fois quand vous êtes au service, qu'on a des patientes qui ont des accès psychotiques en postpartum immédiat et là c'est une prise en charge qui est psychiatrique particulière. Donc ça peut être mineur, comme ça peut être là, c'est le soutien, l'encouragement comme j'ai dit, comme ça peut être vraiment très, très, très psychotique.

C'est vraiment des angoisses, la confusion, du délire, tout ce que vous voulez, on peut passer par là. La chose la plus grave, c'est qu'elles peuvent devenir dangereuses pour leurs enfants. Elles peuvent même violenter leur nouveau-né et donc il faut faire de la séparation pour protéger le nouveau-né et à la maternité, il faut protéger aussi les autres bébés des autres mères.

Je vais passer très vite sur ça parce que c'est de l'anatomie, de la physiologie de la lactation. Pour parler rapidement de la montée laiteuse qui ne se fait pas le premier jour mais qui va se faire quelques jours plus tard, deuxième, troisième jour, donc c'est pas grave mais il faut inciter sur la succion qui doit se faire immédiatement, d'accord? Après, c'est les sucions répétitives et à volonté qui vont permettre d'entretenir la lactation. D'accord? Maintenant pour parler du taux de la prolactine, sachez que la prolactine ne va pas rester très élevée éternellement, d'accord? Mais elle va à un certain moment diminuer, mais malgré ça, c'est les TT qui vont permettre de maintenir la production de la lactée.

Ce ne sont pas des taux de prolactine qui restent très élevés, non. Ils vont diminuer à un certain moment, mais la production de lactée va continuer à cause des TT, de la vidange du sang. Le sang se vide, il y a des informations qui remontent au niveau justement épiphysaire qui vont induire d'un côté la prolactine, mais d'un autre côté, ça va donner aussi des informations locales qui vont faire que les cellules, quand la cellule se vide, vont produire un peu plus.

Mais quand elle est remplie, elle va s'arrêter de produire, d'accord? Et ça, malheureusement, c'est ce qui peut créer des problèmes. Période de croissance, ça veut dire qu'on entretient l'allaitement. Les bienfaits, vous allez le défendre tout seul parce que je pense que vous comprendrez que c'est bon pour la digestion des nouveau-nés, c'est bon pour l'état immunitaire puisqu'on lui donne tout ce qu'il lui faut pour sa défense, c'est bon pour sa croissance, il diminue le risque de diabète, etc.

Et puis la relation mère-enfant, ça c'est un petit point d'interrogation, mais surtout, vous pouvez convaincre les mamans d'allaiter parce que ça va leur permettre de revenir à leur poids initial. C'est un moyen de brûler toutes les réserves qu'ils ont ramassées, d'accord? Et pour le maintenir, il y a toute une hygiène qu'il faut suivre et qui, dans la base, c'est de donner la tétée à volonté. Et bien évidemment, le sein, c'est un organe qui va devenir aussi ouvert au milieu extérieur parce que les canaux galactophores, ça y est, c'est à l'air libre, ils sont manipulés, il y a la succion, il y a les doigts qui touchent et donc c'est une porte d'entrée d'infection.

Et c'est ce qui fait que l'une des complications de l'allaitement maternel les plus graves, on va dire, c'est l'infection. Comment ça va survenir? Alors ici, on parle de crevasses. Crevasses, ce

sont des fissures et des ulcérations sur le mamelon dont la cause principale c'est la mauvaise position de l'allaitement.

Et donc, il faut savoir expliquer par des photos, des images, ça existe, des vidéos, quelles sont les meilleures positions de l'allaitement dans lesquelles on a la rayure presque totale à l'intérieur de la bouche du nouveau-né. Et qu'il soit face, il ne doit pas têter comme ça parce qu'il va tirer le mamelon de façon latérale et c'est la meilleure façon pour créer les blessures. Et ces crevasses, elles vont être douloureuses, mais aussi elles vont être la porte d'entrée pour l'infection du sein en profondeur.

Après, il y a l'engorgement, c'est la mauvaise ou la mauvaise vidange des seins. D'ailleurs, tout à l'heure, on a dit qu'il faut vider pour avoir encore du lait. Il arrive que des patients, ils ont une production assez riche de lait et donc, il y a de l'excès qui échette.

Donc, il faut qu'elle s'assure de la vidange du sein complètement. Donc, on peut faire tirer le lait après la tétée si on sent que le sein reste plein. Parce que le cas contraire, d'abord, la prochaine production ne sera pas bonne.

Deuxièmement, il peut coaguler à l'intérieur du sein et ça va créer de l'engorgement. Ça va boucher un petit peu les canaux et on va avoir son engorgement total ou partiel dans des zones du sein. Et ça, ça va faire mal d'un côté.

D'un autre côté, ça va devenir dur et ça peut se surinfecter par la suite parce que c'est du lait. Le lait, c'est un milieu de culture pour les germes. Même les germes baleaux, si vous les mettez dans un milieu de culture comme le lait, ils vont fleurir.

Donc, il faut savoir traiter ça par des louches chaudes, c'est-à-dire exposer les seins à de l'eau chaude ou à des serviettes très chaudes. Ça permet de relâcher les muscles au niveau des canaux galactophores et ça va permettre de fluidifier le passage. On devrait tirer le lait, parfois faire une restriction hydrique juste le temps de dépasser la phase inflammatoire.

Si c'est important, on peut aussi utiliser l'ocytocine parce que l'ocytocine est une hormone qui participe à l'éjection du lait parce qu'elle fait des contractions au niveau des muscles des parois, des canaux. Quand ça avance et ça s'infecte, on est dans l'étape de la lymphangite aiguë, c'est une inflammation aiguë non suppurée du sein. Donc, inflammation d'un organe, ça va donner bien évidemment la douleur, la rougeur, la tumefaction, mais aussi la fièvre, bien évidemment.

Et là, on est dans une infection sérieuse, d'accord? Et ça, on peut aussi avoir des adénopathies axillaires. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vider, c'est sûr, mais il faut traiter l'inflammation et l'infection. Donc, on peut mettre une antibiothérapie, mais là, on n'a pas besoin de mettre un anti-anaérobie.

On peut aussi mettre l'amoxyciline acétyleulanic. On peut mettre une céphalosporine deuxième

génération par voie orale, ça peut marcher. Et on peut aussi mettre des antistaphes, mais quand on a lait, on ne peut pas prendre les antistaphes.

Et on peut maintenir la vidange, je préfère dire vider le sein, le temps de l'amélioration, et après on peut remettre le bébé à la tête. Et la prévention, seule prévention ici, c'est une bonne vidange du sein et une bonne hygiène. On va y arriver, ne vous en faites pas.

Ça y est, tout. Puis il y a l'abcès. Si ça ne se traite pas, il y a la collection morale, l'infection.

Quand j'ai la collection, c'est l'abcès du sein, et là c'est une situation catastrophique, et c'est vraiment quand c'est suppuré, on va ouvrir et on va avoir un sein complètement ouvert. On va devoir le drainer, regardez comme ici, voilà un sein qui est inflammé en l'infongite, et là il y a l'abcès qui est suppuré. Quand il devient fluctuant, tous les abcès doivent être mis à plat, donc on va l'ouvrir, on va l'évacuer avec l'antibiothérapie.

Voilà, salut Max.